

TRATAMIENTO GENERAL DEL PACIENTE INTOXICADO

Francisco Jesús Callado Moro, María del Carmen Hernández Tuda, Cristina Guemes de la Iglesia.

Lo primero que debe de hacerse ante la sospecha de una intoxicación, es decidir si lo es o no, para lo que deben darse unos pasos previos antes de decidir cualquier tratamiento. Debemos diferenciar intoxicación de sobredosificación para iniciar el tratamiento si está indicado. Posteriormente debe de iniciarse el siguiente proceso:

ANAMNESIS

Ante cualquier sospecha de intoxicación, antes de comenzar una anamnesis y exploración detallada, se debe evaluar rápida y prioritariamente su estado general (respuesta a estímulos verbales o dolorosos, presencia de alteraciones respiratorias, pulsos, etc.) para si fuera necesario comenzar inmediatamente una reanimación cardiopulmonar o aplicar medidas para mantener las funciones vitales.

Si no es precisa la RCP, se debe proceder a una anamnesis convencional que adicionalmente incluirá las siguientes preguntas específicas:

- Nombre del toxico, medicamento, producto de uso doméstico etc.
- Cantidad aproximada que ha ingerido.
- Vía de exposición (importante para el tratamiento).
- Cuanto tiempo ha transcurrido desde la exposición.
- Que síntomas ha tenido antes de llegar al hospital.
- Ha vomitado antes de ser visto.
- Está tomando alguna medicación habitualmente o padece alguna enfermedad.
- Tienen síntomas parecidos otros miembros de la familia (intoxicaciones múltiples que orientaran a intoxicación por CO, setas, etc).

Son de especial interés los antecedentes psiquiátricos (incluyendo la medicación que toman, nombre del psiquiatra habitual) y los intentos previos (número) de suicidio.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Muchas de las manifestaciones clínicas aparecen dentro de las primeras tres horas desde la ingesta o exposición a una sustancia toxica. Aunque a veces, la aparición de la clínica es muy tardía (bastantes horas o incluso días después como en setas hepatotóxicas, paracetamol, aspirina), lo que es importante ya que habrá que ingresar al paciente en espera de su evolución.

Lo mismo ocurre con ciertos medicamentos que llevan más de un principio activo.

EXPLORACIÓN

La exploración clínica deberá de ser completa, y no centrarse solo en la sintomatología teóricamente derivada del tipo de intoxicación al que nos enfrentamos:

- Toma de constantes: pulso, temperatura, tensión arterial y frecuencia respiratoria.
- Observación general del paciente, valorando el nivel de conciencia (utilizando la escala de Glasgow), pupilas, focalidad neurológica, temblor, convulsiones, etc.
- Exploración de la piel, observando la coloración, presencia de signos de ven punción,

quemaduras, sudoración, etc.

- Auscultación pulmonar, para conocer el patrón respiratorio, presencia de material aspirado, etc.
- Auscultación cardíaca, objetivando la presencia y/o grado de arritmias, bradicardia o taquicardia, etc.
- Palpación abdominal.
- Exploración neurológica elemental.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En cuanto a las pruebas analíticas y otras exploraciones complementarias que se deben realizar de forma rutinaria, debe ser el juicio clínico del médico el que las indique. Valorar solicitar en los intoxicados sintomáticos:

- Hemograma.
- Bioquímica que incluya glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, CPK, Mg y Ca (si detergentes, matarratas, etc.).
- Coagulación (si los tóxicos ingeridos sugieren posible alteración de la misma en el momento actual o posteriormente).
- Tóxicos en sangre.
- Tóxicos en orina.
- Gasometría arterial (si coma, broncoespasmo, etc.).
- Co-oximetría (si sospecha CO o incendio).
- Radiografía de tórax y simple de abdomen (esta última, si sospecha toxico radiopaco).
- Electrocardiograma.

TRATAMIENTO GENERAL DE LAS INTOXICACIONES AGUDAS

Lo primero que deberemos valorar es cuando sospechar una intoxicación, excepto en el caso en el que nos lo indique el paciente o los acompañantes directamente.

Debemos sospechar una intoxicación en los siguientes supuestos:

- Pacientes psiquiátricos con síntomas anómalos.
- TCE con mala evolución no justificada.
- Comas no filiados en jóvenes de 12 a 35 años.
- Acidosis metabólicas no explicadas.
- Fracaso hepático o renal.
- Arritmias graves en niños o jóvenes sin patología previa.
- Niños con síntomas poco habituales o de presentación súbita.
- Deterioro multiorgánico.

Pueden darse tres situaciones:

Paciente en PCR

Se procederá a la RCP avanzada. En las últimas actualizaciones de la RCP avanzada, las normas ILCOR de 2015 aportan además la utilización de la Naloxona por legos y la utilización de la Emulsión intravenosa de Lípidos. Se adjuntan las recomendaciones específicas: “Se recomienda entrenar a legos y personal sanitario en la Intoxicación por opiáceos incluyendo administración de Naloxona (2 mg vía intranasal o 0,4 mg vía i.m. y repetir dosis a los 4 minutos),

a personas de riesgo o personas en contacto con ellas (Clase IIa). Se recomienda incluir esta formación en los primeros auxilios". "Utilizar emulsión intravenosa de lípidos (EIVL), en intoxicaciones con anestésicos locales y otros fármacos. Se aconseja EIVL, combinada con reanimación estándar a pacientes con neurotoxicidad premonitoria o toxicidad por anestésicos locales. Puede ser razonable EIVL en pacientes con toxicidad farmacológica que no responden a medidas de reanimación estándar"

Paciente en coma

Se procederá a aplicar el protocolo de coma de origen desconocido:

- Colocación de una vía venosa y administración de oxígeno en mascarilla al 50%
- Antes de comenzar a perfundir suero salino al 0,9%, extraer muestra de sangre y pedir sistemático de sangre y bioquímica.
- Administrar 0,8 mg i.v. (i.m. si no hay vía) de naloxona (2 ampollas de Naloxone®), glucosa al 33% (2 ampollas de Glucosmon®, repetible si fuese preciso), tiamina 100 mg i.m (1 ampolla de Benerva®) solo si se sospecha alcoholismo crónico y considerar la necesidad o "no" de flumazenilo a dosis de 0,25 mg. (2,5 ml. de Anexate ®) cada minuto hasta 2 mg (4 ampollas de 0,5 mg). si se sospecha intoxicación por benzodiacepinas (está contraindicado inicialmente en la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, epilepsia, cocaína y carbamazepina).
- Comenzar a perfundir suero salino al 0,9%.
- En cualquier caso, aunque no exista compromiso de las funciones vitales, siempre o casi siempre perfundir lentamente un S. glucosado 5% o S. salino 0,9% para mantener una vía venosa permeable.

Paciente consciente

Prevención De Una Mayor Absorción Del Tóxico

Si toxico por vía oral

Lavado gástrico, indicado en las primeras 1-2 horas. Puede retrasarse en ingesta de sólidos, comidas copiosas, sustancias liposolubles, shock. A los 5 minutos de la ingesta disminuye la absorción un 52%. A la hora sólo un 16%. Es menos eficaz que sólo el carbón activado. No hacerlo nunca como castigo. Usarlo en sustancias que no son adsorbidas por el carbón activado como litio, hierro. Si es un anticolinérgico se puede hacer hasta 4 h después. No indicado en poca cantidad del producto o poca toxicidad. No indicado en cáusticos o derivados del petróleo. No hacer en paciente con convulsiones. No en paciente inconsciente sin intubar. Si no se hace con buena técnica y en el momento adecuado probablemente sea mejor no hacerlo.

Técnica: Decúbito lateral izquierdo y rodillas flexionadas. Posición de Trendelenburg. Sonda bien lubricada. Aspirar contenido gástrico con jeringa. Introducir 200-300 cc de agua y dejar salir. Repetir hasta que salga el agua limpia. Pinzar la sonda al retirarla para evitar broncoaspiraciones.

Carbón activado, dosis única de 50 g. (un envase) tras el lavado (no olvidar que es tan eficaz o más que el propio lavado). Está contraindicado y/o no es eficaz tras la ingesta de cáusticos (ácidos o álcalis), derivados del petróleo, barnices, paciente en coma (sin intubar), convulsiones, ingesta alcoholes (etanol, metanol, etilenglicol), cianuro, metales (hierro, litio, plomo) y potasio. La adsorción del xenobiótico es muy rápida siendo el 90% en 1 minuto. Se reduce la absorción del tóxico el 90% si se administra en la primera hora.

Laxantes Actualmente en desuso, solo tras el carbón activado para evitar impactaciones. Indicados en productos de absorción lenta y derivados del petróleo. Después del carbón activado. Contraindicados en obstrucción intestinal, diarrea importante o sustancia corrosivas. Se utilizan:

Sulfato magnésico: 30gr en 250 ml de agua. (Contraindicado en I renal). Sulfato sódico: 30 gr en 250 ml de agua. (Contraindicado en I cardíaca). Duphalac (lactulosa). Sobres de 10 gr. Hidróxido de magnesio: 30 ml de solución al 7-8%. Sorbitol: 70 ml al 70% cada 4 horas.

Lavado intestinal total: en ingesta masiva de preparados de liberación retardada (litio). Pilas de botón. Body packers y body stuffers. Se usa mediante SNG solución electrolítica de polietilenglicol (solución evacuante Bohon) a ritmo de 1,5-2 l/h en adulto y 0,5 ml/ en niños.

Endoscopia y Cirugía: para extraer cuerpos extraños o sustancias radiopacas, concreciones de comprimidos, grandes cantidades de metales pesados o paquetes de drogas de abuso si hay posible rotura del envoltorio.

La emesis forzada está en desuso.

Si tóxico por vía respiratoria

Separar al paciente del ambiente contaminado y administrar oxígeno (al 100% si se trata de CO). Si son gases irritantes que generan broncoespasmo y tos será necesario valorar si precisa la administración de: salbutamol en la mascarilla (**Ventolin**® 0.5-1 ml en 3 ml de S. salino 0.9% repetible si precisa), hidrocortisona (**Actocortina**®) 100 o 500 mg. i.v. repetible si precisa, etc.

Si tóxico por vía ocular

Lavado del ojo con suero Fisiológico durante 15-20 minutos, seguidamente deberá siempre ser valorado y tratado por un Oftalmólogo.

Si tóxico por vía cutánea

Si está contaminada la piel y ropas por sustancias tóxicas (pesticidas, etc.) o causticas debe ser tratado mediante la retirada de la ropa (utilizando guantes) y el lavado inmediato de la zona con agua (caso de los cáusticos) y jabón (caso de pesticidas) durante 10-15 minutos.

Incremento De La Eliminación Del Tóxico

El objetivo es forzar la eliminación del tóxico; que se realizaría mediante la depuración renal (diuresis forzada) o extrarrenal (hemodiálisis, hemoperfusión, plasmaféresis y exanguinotransfusión). Son en general técnicas agresivas, no carentes de peligros y con indicaciones escasas y muy concretas que nunca hay que hacer en el Servicio de Urgencias, sino en UVI y/o Nefrología. Diuréticos de asa como la Furosemida pueden disminuir el riesgo de sobrecarga, pero aumentan riesgo de hipopotasemia y acidosis metabólica, por lo tanto, la técnica de forzar diuresis con **Seguril**® no está indicada.

Tratamiento Antidótico

Los antidotos pueden utilizarse en los casos en que se conoce el tóxico y hay antidoto específico (desgraciadamente en pocos casos). Pueden usarse antidotos químicos (azul de metileno, etc.); Quelantes (BAL, EDTA, Penicilamina, etc.); Sustitutivos (ácido fólico, alcohol etílico, etc.); Biológicos (toxina botulínica, toxinas de serpientes, etc.); Fisiológicos (atropina, Fisostigmina, Naloxona, etc.).

Tratamiento Sintomático Y De Las Complicaciones

En muchos casos una parte del tratamiento consiste en mantener las constantes vitales, la observación y monitorización del paciente y tratar los síntomas y complicaciones (arritmias, convulsiones, agitación, shock, etc.) surgidas durante el cuadro tóxico.

Tratar de la forma habitual: convulsiones (diacepam i.v. lenta), hipotensión (líquidos, etc.), hipotermia (calentar paciente), hipertermia (enfriar, paracetamol, medidas físicas, etc.), agitación (diacepam i.v. como primera elección, haloperidol i.m. o i.v. etc.).

Tratamiento Psiquiátrico

Todos los pacientes con intento autolítico deben ser valorados y/o tratados por un psiquiatra previo al alta, siempre que estén conscientes y con posibilidad de valoración.

Parte Judicial

Es obligatorio comunicar al juez de guardia, mediante el correspondiente parte judicial, que se ha atendido una intoxicación aguda de cualquier origen o intencionalidad.

Criterios De Ingreso

- Ingreso en observación o en UCI dependiendo de la gravedad.
- Al menos 12 horas de observación en toda intoxicación aguda.
- Ingresar en: Ausencia de síntomas si es un tóxico tardío. Gran cantidad de tóxico ingerido. Por indicación del psiquiatra.

BIBLIOGRAFÍA

- Dueñas Laita,a; Pérez Castrillón, JL. Manejo del paciente intoxicado. En: Callado Moro, FJ; Richard Espiga, F. Urgencias en Medicina, Ed. Librería Berceo, 5ª edición, 2012. P. 647-51.
- Nogué Xarau, Santiago. En: Intoxicaciones agudas. Bases para el tratamiento en un Servicio de Urgencias... Laboratorios Menarini S.A. 2010.
- Dueñas A. Intoxicaciones agudas en medicina de urgencia y cuidados críticos. Barcelona: Masson, S.A.; 1999. Nogué Xarau S., Munne Mas P, Nicolás Arcelis et al. Intoxicaciones agudas. Protocolos de tratamiento. Barcelona: MT editores S.L.; 2003.